



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 בדצמבר 2025

1913

כ"ה בכסלו התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 20) (מסירת מידע לצורך מניעת פגיעה), התשפ"ו-2025 406

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 20) (מסירת מידע לצורך מניעת פגיעה), התשפ"ו-2025

תיקון סעיף 20 1. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 20 –

ד ב ר י ה ס ב ר

סוציאלי שמונה לפי חוק, או למשטרה. כמו כן בסעיף 368ד(22) לחוק העונשין חלה חובה על אותם בעלי המקצוע לדווח לעובד סוציאלי כאמור או למשטרה על יסוד סביר לחשד כי נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין על ידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנים. בסעיפים אלה חובת הדיווח חלה רק בנוגע לחשד לעבירות שובצעו בלבד ולא ביחס לחשש לפגיעה עתידית. כמו כן הסעיף מתייחס רק לפגיעה בקטנים על ידי אחראי או לפגיעה מינית על ידי בן משפחה קטין;

3. סעיף 262 לחוק העונשין קובע חובה כללית לפעול למניעת פשעים. הסעיף קובע כי מי שידע שפלוני זומם לבצע פשע, חייב לנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את עשייתו או את השלמתו. סעיף זה אומנם חל ביחס לעבירות עתידיות, אבל הוא מוגבל לעבירות מסוג פשע בלבד (עבירות שהעונש בצידן 4 שנות מאסר ומעלה). כמו כן, לפי הפסיקה, הכלל בדבר "עצימת עיניים" שמאפשר לייחס מודעות לרכיב בעבירה למי שהיה לו חשד ממשי כי הוא מתקיים ונמנע מלברר אותו, אינו חל ביחס לעבירות אי-מניעת פשע, ולכן סעיף זה חל רק ביחס לידיעה של ממש. מטבע הדברים, ישנם מצבים רבים שבהם קיים חשש בלבד ולא ידיעה של ממש. על כל פנים, מדובר בחובה שחלה על כלל הציבור, כאמור, ולא בהקשר מקצועי בלבד, ולכן היא מפורשת בצמצום ונאכפת במקרים נדירים יחסית;

4. סעיף 20א(5) לחוק זכויות החולה קובע שמטפל יכול להעביר מידע לאחר כאשר המידע חיוני להגנה על בריאות הוולת או הציבור ובכפוף להחלטת ועדת אתיקה בנושא, לאחר שנתנה למטופל הזדמנות להשמיע את דבריו לפניו. סעיף זה עוסק בהגנה על בריאות הציבור (למשל מפני מחלות מידבקת) ולא ברור שהוא חל גם ביחס לחשש לפגיעה כתוצאה מאלימות. מכל מקום, במסירת מידע לפי סעיף זה יש צורך בהפעלת מנגנון מסורבל של ועדת אתיקה ושמיעת המטופל לפניו, דבר שיכול לעכב את מסירת המידע ולהחריף את הסכנה הצפויה. נוסף על כך, במקרים שבהם ישנו חשש לפגיעה עצמית ואיומי אובדנות של המטופל, שמיעת המטופל לפני ועדת האתיקה עלולה להביא להחרפת הסכנה הנשקפת ולסיכול האפשרות למניעת הפגיעה הצפויה. לפיכך החוק הקיים אינו נותן פתרון כולל להעברת מידע על ידי מטפלים לצורך מניעת פגיעה;

5. סעיף 42 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, קובע, בין השאר, אפשרות לגלות את המידע אם המידע דרוש לשם טיפול באותו אדם, אם מוסר המידע קיבל הרשאה למסירת

כללי בסעיף 19 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק). מעוגנת החובה החלה על מטפלים לשמור על סודיות מידע הנוגע למטופל, אשר הגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם. בסעיף 20 לחוק קבועים החריגים לכלל, שבהם ניתן להעביר מידע רפואי לאחר, כגון הסכמת המטופל להעברת המידע, חובה על פי דין להעברת המידע, מידע המועבר למטפל אחר לצורך טיפול במטופל ועוד. סעיף 20 לחוק לא כולל התייחסות למקרים שבהם העברת המידע נדרשת לצורך מניעת פגיעה אפשרית באדם אשר העביר את המידע למטפל (לדוגמה מטופל המביע לפני המטפל רצון לפגוע בעצמו או המביע חשש כי הוא עומד להיפגע על ידי אדם אחר), או לצורך מניעת פגיעה בצד ג' שאינו המטופל (לדוגמה מטופל אשר במהלך הטיפול בו עולה כי הוא מהווה איום ממשי כלפי בן משפחתו, או מטופל המדווח למטפל במהלך הטיפול בו על מידע בנוגע לאדם אחר המצוי בסכנת פגיעה על ידי צד ג' וכיוצא בזה).

זאת ועוד, ישנם מקרים שבהם המטפל נחשף למידע אשר יכול להצביע על חשש לפגיעה עתידית בקטין, בחסר ישע ואף באדם בגיר (בין שהמטופל מסר מידע בנוגע לפגיעה אפשרית בעצמו ובין שמסר מידע בנוגע לפגיעה אפשרית בוולתו). ואולם, בשל העובדה כי העברת מידע בנוגע לחשש עתידי לפגיעה לא הוסדרה בדין ובשל החשש מפני הפרת חובת הסודיות הרפואית החלה על המטפל לפי דין, נמנע המטפל מלהעביר את המידע לגורם רלוונטי שייתכן שיוכל למנוע את הפגיעה העתידית.

בכמה דברי חקיקה קיימות הוראות חוק המאפשרות לחרוג מחובת סודיות החלה על הגורם המקצועי אשר לפניו נמסר המידע, אך הוראות אלה אינן מהוות פתרון לחשש של מטפלים מפני הפרת חובת הסודיות כאמור לצורך מניעת פגיעה במטופל או באדם אחר. כך למשל:

1. סעיף 8א(4) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, קובע כי עובד סוציאלי רשאי לחרוג מחובת הסודיות החלה עליו, בין השאר כאשר "הגילוי דרוש לשם מניעת פגיעה באדם שעליו המידע או באדם אחר";

2. סעיף 368ד(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), קובע כי במקרים שבהם היה לבעלי מקצוע שונים, ובכלל זה רופא, אחות, עובד סוציאלי, פסיכולוג ועוסק במקצוע פרה-רפואי, עקב עיסוקם, יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי אחראי עליו, חלה עליהם החובה לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשפ"ה, עמ' 530.

(א) אחרי פסקה (5) יבוא:

”(א5) לדעת המטפל, קיים חשש ממשי לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של קטין או חסר ישע, בין שהוא המטפל ובין שאינו המטפל, ומסירת המידע הרפואי נדרשת לשם התערבות וטיפול למניעת פגיעה כאמור;

(ב5) לדעת המטפל, קיים חשש ממשי לפגיעה חמורה וממשית בשלומו הגופני או הנפשי של בגיר שאינו חסר ישע, בין שהוא המטפל ובין שאינו המטפל, ומסירת המידע הרפואי נדרשת לשם התערבות וטיפול למניעת פגיעה כאמור; טרם מסירת המידע, ראוי המטפל להתייעץ עם ועדה מייעצת שמינה המנהל הכללי או מי שהמנהל הכללי הסמיכו לעניין זה;”;

דברי הסבר

(2025), ובהם צוין, בין השאר, כי טרם הושלמו הליכי הסדרה בהתאם להמלצות הוועדות האמורות.

לפיכך מוצע בהצעת חוק זו לאפשר למטפלים, כהגדרתם בחוק, למסור מידע כאמור אל גופים אלה לטובת הגנה על הציבור ולאפשר נקיטת פעולות נוספות, ככל שיידרש, שעשויות למנוע את הפגיעה.

השפעת החוק המוצע על זכויות הילד: התיקון המוצע ירחיב את ההגנה על קטינים, מעבר להגנה הקיימת כיום במסגרת חובת הדיווח לפי סעיף 368 לחוק העונשין, והתקווה היא שהוא יאפשר למנוע פגיעה בקטינים מבעוד מועד.

סעיף מוצע להוסיף לסעיף 20(א) לחוק את פסקאות 1(א) ו-1(א5) ו-25(ב) כנוסחן המוצע, שבהן מפורטים המקרים שבהם המטפל יהיה ראוי להפעיל את מנגנון העברת המידע לשם מניעת הפגיעה.

פסקה (א5) המוצעת מתייחסת לנסיבות שבהן קיים חשש ממשי לפגיעה (גם פגיעה שאינה חמורה וממשית) בשלומו הגופני או הנפשי של קטין או חסר ישע, בין שהוא המטפל ובין שהוא קטין או חסר ישע אחר, והעברת המידע דרושה לשם התערבות וטיפול למניעת הפגיעה. תנאי להעברת המידע הוא כי לדעת המטפל מדובר בחשש ממשי לפגיעה. עם זאת, מכיוון שמדובר בקטין או בחסר ישע, רף הפגיעה נמוך יותר ואין צורך בחשש לפגיעה חמורה וממשית כתנאי להעברת המידע.

פסקה (ב5) המוצעת מתייחסת לנסיבות שבהן לדעת המטפל קיים חשש ממשי לפגיעה חמורה וממשית בשלומו הגופני או הנפשי של מטופל בגיר שאינו חסר ישע, בין שהוא המטפל ובין שהוא אדם אחר, והעברת המידע דרושה לשם התערבות וטיפול למניעת הפגיעה. הצורך בפגיעה חמורה וממשית במקרה של בגיר, נועד לבטא את האיזון הדרוש בין החובה לשמור על סודיות המידע הרפואי ובין הצורך במניעת פגיעה, כאשר במקרה של חשש לפגיעה בשלומו של קטין או חסר ישע, די בחשש לפגיעה כלשהי אף שאינה חמורה וממשית ואילו בחשש לפגיעה בבגיר – יש צורך בחשש לפגיעה חמורה וממשית.

המידע על ידי בית המשפט, או שקיימת חובה או רשות בחוק לגלות את המידע. סעיף זה אינו נותן פתרון להעברת מידע לצורך הגנה על אדם אחר מפני פגיעה עתידית, מקום שבו לא חלה חובה לפי עבירת אי-מניעת פשע.

בשל הצורך לאפשר העברת מידע במקרים נוספים, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע הסדר שעל פיו המטפל יהיה ראוי להעביר מידע לצורך מניעת פגיעה, בתנאים המפורטים בהצעה, אל הגופים הרלוונטיים. יודגש כי מסירת “מידע רפואי” לפי החוק המוצע כוללת כל מידע שהגיע אל המטפל אגב הטיפול הרפואי לרבות מידע הנוגע לפגיעה במטופל או באדם אחר, שכן כל מידע כאמור שהגיע תוך כדי מילוי תפקידו של המטפל נחשב ככזה הנוגע ישירות למטופל.

נוסף על כך, בסעיף 20 לחוק לא מוסדרת כיום האפשרות למסור מידע שהתקבל על ידי מטופל לגורמים ממשלתיים האמונים על בחינת אירועים, הפקת לקחים וגיבוש מדיניות בסוגיות הנוגעות להגנה על שלום הציבור לצורך לימוד ההתנהלות ומניעת הישנות של מקרים דומים בעתיד. מכיוון שישנם מקרים שבהם הדבר נדרש, מוצע במסגרת החוק לקבוע סמכות להעביר את המידע.

נושא העברות מידע ממטפלים לגורמים רלוונטיים אחרים, עלה בוועדות הבין-משרדיות לטיפול ומניעת אלימות במשפחה בשנים 1998 ו-2016, ובהמשך לכך במסגרת תוכנית ליישום המלצות הוועדה הבין-משרדית לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, גם הומלץ על תיקון חקיקה בנושא.

המלצה זו אומצה עקרונית בהחלטת הממשלה מספר 5006 מיום ט' בסיוון התשנ”ט (24 במאי 1999) ובהחלטת הממשלה מספר 2820 מיום י”ג בתמוז התשע”ז (7 ביולי 2017), שבהן ניתנו הנחיות, בין השאר, בנוגע לשיתוף הפעולה בהעברת המידע בין הגופים השונים האמונים על התמודדות עם תופעות אלה.

הצורך בהסדרת נושא זה עלה גם בדוח מבקר המדינה בעניין – “ההתמודדות עם תופעת האלימות בן בני זוג” אשר פורסם ביום כ’ בתמוז התשפ”א (30 ביוני 2021) ובדוח המעקב אשר פורסם ביום כ”ז בתמוז התשפ”ה (23 ביולי

"(8) מסירת המידע הרפואי היא לגוף ציבורי, המנוי בתוספת השלישית לחוק, למטרות בחינת אירועים שאירעו בעבר לצורך הפקת לקחים וגיבוש מדיניות לטובת הציבור והגנתו, וכן לשם בחינת דרכי הטיפול וההתערבות בכל הנוגע לאותם אירועים ולמטרות אלה בלבד; השר רשאי, בצו, להוסיף לתוספת השלישית גוף ציבורי אחר לבקשת השר הממונה על אותו גוף";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) (1) מסירת מידע לפי סעיף קטן (א)(5) תהיה למשטרת ישראל או למנהל המחלקה לשירותים חברתיים או לעובד סוציאלי מטעמו ברשות המקומית שבתחומה נמצא מקום מגוריו של האדם שלגביו התעורר החשש לפגיעה. (2) מסירת מידע לפי סעיף קטן (א)(5) תהיה למשטרת ישראל; אם הבגיר שלגביו התעורר החשש לפגיעה הוא בן משפחה מדרגה ראשונה של האדם אשר לגביו התעורר החשש כי יפגע בו, יימסר המידע למשטרת ישראל או למנהל המחלקה לשירותים חברתיים או לעובד סוציאלי מטעמו ברשות המקומית שבתחומה מתגורר האדם שלגביו התעורר החשש לפגיעה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף 2 מוצע להוסיף את התוספת השלישית לחוק, אשר תכלול את הגוף הציבורי שאליו יהיה ניתן להעביר מידע לפי סעיף 20(א)(8) המוצע. הגוף הנכלל בתוספת המוצעת הוא הוועדה לבדיקת מקרי רצח במשפחה שהוקמה לפי החלטת הממשלה מספר 820 (תמ/42) מיום ד' בסיוון התשס"ב (15 במאי 2002), ואשר סמכויותיה הורחבו בהמשך בהחלטת הממשלה מספר 1821 מיום י"ז באב התשפ"ב (14 באוגוסט 2022).

סעיף 1(2) בסעיף 1(2) מוצע להוסיף לסעיף 20 לחוק את סעיפים קטנים (א) עד (4) כנוסחם המוצע, כמפורט להלן.

לסעיף קטן (1א) המוצע

מוצע לקבוע את הגורמים ש אליהם יועבר המידע לפי סעיף 1(1א) המוצע, לפי העניין: כאשר מדובר בחשש לפגיעה בבגיר – המידע יועבר למשטרת ישראל; במקרה שבו מתעורר חשש לפגיעה בקטין או בחסר ישע או חשש לפגיעה בבגיר על ידי בן משפחתו מדרגה ראשונה – תתאפשר העברת המידע למשטרת ישראל או למנהל המחלקה לשירותים חברתיים או מי מטעמו ברשות המקומית שבתחומה מתגורר האדם שלגביו התעורר החשש לפגיעה (בין שמדובר במטופל ובין שמדובר באדם אחר). זאת בהתאם לנסיבות. עוד יצוין כי בכוונת משרד הבריאות לפרסם נוהל רלוונטי שייכתב בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל וגורמי משרד הרווחה, ובו יפורט, בין השאר, דוגמאות למקרים שבהם ניתן להעביר את המידע למשטרת ישראל או לגורמי הרווחה.

כחלק מהאיזון האמור, בחשש לפגיעה בבגיר, רשאי המטפל להתייעץ עם ועדה מייעצת שימנה המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הכללי הסמיכו לעניין זה, בשאלה אם להעביר את המידע או לא. יובהר כי כיום פועלות ועדות כאמור מכוח חוזר מנהל כללי של משרד הבריאות (מספר 26/03) – "מינוי ועדות קבועות לנושא אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטנים וחסרי ישע". ועדות אלה קיימות כיום בבתי חולים, בלשכות הבריאות, במחוזות קופות החולים ובמרפאות לבריאות הנפש. בכוונת משרד הבריאות, עם התקדמות הליכי החקיקה, לשקול למנות ועדות כאמור אשר ייעצו גם בעניינם של בגירים ואשר ייעצו גם למטפלים המקבלים מטופלים באופן פרטי נוסף על המסגרות המפורטות כיום בחוזר המנהל הכללי.

סעיף והתוספת השלישית

1(1א) (ב) בסעיף 1(1) (ב) מוצע להסדיר את האפשרות להעברת המידע לגוף ציבורי, לרבות ועדה ציבורית, המנוי בתוספת השלישית לחוק. עוד מוצע בסעיף 1(4) להוסיף הגדרה ל"גוף ציבורי" אשר מפנה להגדרה בחוק הגנת הפרטיות, כך שיהיה ניתן להוסיף לתוספת השלישית רק ועדה ציבורית שעונה על ההגדרה של גוף ציבורי לפי חוק הגנת הפרטיות (כלומר "משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין"). המידע יועבר אך ורק לשם המטרה הקבועה בסעיף – בדיקה והערכה של אירועים שאירעו בעבר לצורך הפקת לקחים, גיבוש מדיניות לטובת הציבור והגנתו, וכן לשם בחינת דרכי טיפול או מניעת פגיעה עתידית. כמו כן קובע הסעיף כי שר הבריאות, לבקשת השר הרלוונטי (השר הממונה על אותו הגוף), רשאי להוסיף, בצו, גוף ציבורי אחר לתוספת השלישית.

(2א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 16א, מידע כאמור בסעיף קטן (א)(5) יימסר רק לאחר שהמטפל יידע את ההורה של הקטין, את האפטרופוס של הקטין או חסר הישע או את מיופה הכוח של חסר הישע בדבר מסירת המידע, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

- (1) לדעת המטפל, קיים חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או חסר הישע, על ידי ההורה, האפטרופוס, מיופה הכוח, או בן משפחה של הקטין או חסר הישע;
- (2) לדעת המטפל, יידוע ההורה או האפטרופוס של הקטין או יידוע האפטרופוס או מיופה הכוח של חסר הישע עלול להביא לפגיעה בטיפול בקטין או בחסר הישע או לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או חסר הישע כאמור, או בשלומו הגופני או הנפשי של אדם אחר;
- (3) המידע הוא על קטין מעל גיל 14, והקטין ביקש שלא ליידע את הורו או את האפטרופוס שלו;
- (4) לא ניתן במאמץ סביר לאתר את ההורה, או את האפטרופוס או את מיופה הכוח וליידע אותו כאמור, ולדעת המטפל יש למסור את המידע בלא דיחוי;
- (5) לעניין יידוע של הורה – למעט הורה שנשללה אפטרופסתו לפי כל דין או שהוגבלה סמכותו לקבלת מידע על אודות הקטין לפי כל דין.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (2א) המוצע

קטין מתחת לגיל 14 לקטין מעל גיל 14 קיימת בכמה הוראות חקיקה. כך למשל בחקירתו של עד קטין, בחקירת קטין נפגע עבירה, במשך הזמן להבאה לפני שופט ועוד. גם בהנחיות הקיימות במערכת הבריאות ישנה הבחנה דומה – בחזר מינהל רפואה 4/2004 "ביקורי קטינים במרפאה ראשונית ללא מלווה", נקבע, בין השאר, כי ככלל מטפל רשאי לבצע בדיקה או טיפול רפואי שגרתי בקטין שמלאו לו 14 שנים, גם בלא הסכמה מפורשת של הורה או נוכחות מלווה מטעמו, בכפוף לקבלת הסכמה מדעת שניתנה על ידי הקטין עצמו. בהתאם, גם במקרה זה מוצע לאפשר שיקול דעת לקטין מעל גיל 14 אשר אינו מעוניין כי יידעו את הוריו במידע אשר מסר למטפל;

4. לא ניתן לאתר את ההורה או האפטרופוס וליידע אותו, אף על פי שנעשה מאמץ סביר לאתרו, ונדרש להעביר את המידע בלא עיכוב;

5. לעניין יידוע של הורה – המידע לא יועבר להורה אשר נשללה אפטרופסתו או הוגבלה סמכותו לקבלת המידע לפי כל דין. זאת כדי לתת מענה למקרים שבהם נשללה אפטרופסתו, בין מכוח הדין (ראו סעיף 27א לחוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – חוק הכשרות המשפטית)), ובין מכוח החלטת בית המשפט בהתאם לחוק הכשרות המשפטית.

מוצע כי במסגרת האיוון בין האפשרות להסרת החיסיון הרפואי והעברת המידע לבין חובת שמירת הסודיות, ייקבע תנאי נוסף להעברת המידע כאשר מדובר בפגיעה בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 20(א)(5) המוצע, ולפיו, טרם העברת המידע, יידע המטפל את ההורה של הקטין או את האפטרופוס של הקטין או חסר הישע או את מיופה הכוח של חסר הישע, לפי העניין, בדבר כוונתו להעביר את המידע. זאת, בלי לגרוע מהוראות סעיף 16א לחוק, בעניין טיפול רפואי בקטין שהורה הורשע או מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו.

המטפל לא יידע גורמים כאמור אם סבר כי מתקיים אחד מאלה:

1. לדעת המטפל, קיים חשש לפגיעה בשלומו של הקטין או חסר הישע על ידי ההורה, האפטרופוס, מיופה הכוח או בן משפחה של הקטין או חסר הישע;
2. לדעת המטפל, היידוע האמור עלול להביא לפגיעה בטיפול בקטין, או בשלומו של הקטין או חסר הישע, או בשלומו הגופני או הנפשי של אדם אחר;
3. מדובר בקטין מעל גיל 14 המבקש שלא ליידע את הורו או את האפטרופוס שלו. יובהר כי ההבחנה בין

(א3) המטפל ימסור מידע כאמור בסעיף קטן (א)(ב5) רק לאחר שיידע את המטופל על כוונתו למסור את המידע וביקש את הסכמתו להעברת המידע; ואולם, אם סבר המטפל כי היידוע או בקשת ההסכמה עלולים לסכל את מניעת הפגיעה במטופל או באדם אחר כאמור באותו סעיף קטן או כי לא ניתן לאתר את המטופל לאחר שנעשה מאמץ סביר לאתר ויש להעביר את המידע בלא דיחוי – ימסור המטפל את המידע האמור בלי ליידע את המטופל.

(א4) קיבל חבר גוף ציבורי מידע כאמור בסעיף (א)(8), לא יעשה בו כל שימוש אלא לפי אותו סעיף קטן, וימחק את המידע כשאינו דרוש עוד, והכול במידה הנדרשת לשם יישום התכלית כאמור;

(3) בסעיף קטן (ג) –

(א) האמור בו יסומן "(1)";

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) על אף האמור בפסקה (1), קיבל אדם מידע לפי פסקאות (א5) או (ב5) לסעיף קטן (א), במסגרת מילוי תפקידו לפי דין, יחולו לעניין העברת המידע הוראות הדין החלות עליו מתוקף תפקידו, ובלבד שהעברת המידע היא לשם מניעת הפגיעה כאמור בפסקאות האמורות";

(4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) בסעיף זה –

"בן משפחה מדרגה ראשונה" – בן זוג, בן זוג לשעבר, הורה, ילה, אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה;

ד ב ר י ה ס ב ר

מזהים, בהסתמך על המידע שהועבר, ואולם כל המידע הגולמי שהועבר יימחק כשאינו דרוש עוד.

סעיף 1(3) מוצע להוסיף את סעיף קטן (ג)(2) שבמסגרתו ייקבע כי על אף האמור בסעיף 20(ג) שעניינו שמירת סודיות רפואית על ידי מטפל או עובד מוסד רפואי ונקיטת אמצעים הדרושים לצורך הבטחת שמירת סודיות זו, אם קיבל אדם מידע ממטפל לצורך מניעת פגיעה, במסגרת מילוי תפקידו לפי דין, והוא מעוניין להעביר את המידע לגורמים נוספים, יחולו לעניין העברת המידע הוראות הדין החלות עליו מתוקף תפקידו, ובלבד שהעברת המידע היא לשם מניעת הפגיעה שאותה ביקש המטפל אשר העביר את המידע למנוע.

סעיף 1(4) מוצע להוסיף אל סעיף 20 לחוק את סעיף קטן (ד) ולהגדיר בו כמה מונחים הנדרשים לצורך השינויים המוצעים בסעיף זה.

להגדרה "בן משפחה" – מוצע לכלול בהגדרה זו בן זוג, בן זוג לשעבר, הורה, ילה, אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה.

לסעיף קטן (א3) המוצע

מוצע כי לגבי מסירת מידע בנוגע לבגיר לפי סעיף 20(א)(ב5) המוצע – המידע יימסר רק לאחר שהמטפל יידע את המטופל על כוונתו למסירת המידע ויבקש את הסכמתו לכך, אלא אם כן סבר המטפל כי היידוע או בקשת ההסכמה עלולים לסכל את מניעת הפגיעה או כי לא ניתן לאתר את המטופל לאחר מאמץ סביר ויש להעביר את המידע בלא דיחוי. כאמור בדברי ההסבר לסעיף 1(1)(א) המוצע, מטפל המתלבט אם למסור את המידע יוכל להתייעץ על כך עם ועדה שמונתה על ידי המנהל הכללי לעניין זה.

לסעיף קטן (א4) המוצע

מוצע לקבוע כי במסגרת האיזון בין השמירה על סודיות המידע הרפואי לבין תכליות טובת הציבור, המידע אשר יובא לידיעת חברי הגוף או הוועדה שבתוספת השלישית יישמר בסוד ולא ייעשה בו שימוש אלא לשם התכלית האמורה בסעיף קטן (א)(8) המוצע. בכלל זה, המידע לא יועבר לגוף חוקר אלא לצורך התייעצות בקשר להערכה המשותפת או יישומה או לצורך הפקת לקחים שקרו בעבר, במסגרת הגוף הציבורי שהם מייצגים בלבד. נוסף על כך, יהיה ניתן להפיק תוצרים כלליים, בלא פרטים

"גוף ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 23(1) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981,²
 לרבות ועדה ציבורית;
 "חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין, התשל"ז-1977;³
 "מיופה כוח" – כמשמעותו בפרק שני לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
 התשכ"ב-1962.⁴

הוספת תוספת
 שלישית

2. אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת שלישית"

(סעיף 20(א)(8))

1. הוועדה לבדיקת מקרי רצח נשים בידי בן משפחה שהוקמה לפי החלטת הממשלה
 מספר 820 (תמ/42) מיום ד' בסיוון התשס"ב (15 במאי 2002).

ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה "גוף ציבורי" – מוצע להחיל את ההגדרה הקבועה
 בסעיף 23(1) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981: משרדי
 הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף
 אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין; לרבות ועדה
 ציבורית.
 להגדרה "חסר ישע" – מוצע להחיל את ההגדרה הקבועה
 בסעיף 368א לחוק העונשין.

להגדרה "מיופה כוח" – מוצע להגדירו כמשמעותו
 בפרק שני לחוק הכשרות המשפטית, לרבות בעניינים
 אישיים ורכשיים (שאם לא צוין אחרת, כולל גם יפוי כוח
 לעניינים בריאותיים בהתאם לסעיף 32(ג) לחוק הכשרות
 המשפטית).

² ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁴ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.

